MINISTERIO DE SALUD

No.046-2026/MINSA

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Ministerial

Lima, 23 de ENERO del 2026

Visto, el Expediente N° DGIESP-DMUNI20260000043, que contiene el Informe N° D000011-2026-DGIESP-DMUNI-MINSA y la Nota Informativa N° D000107-2026-DGIESP-MINSA de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública; y, el Informe N° D000037-2026-OGAJ-MINSA de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, disponen que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, y que la protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla;

Que, la Ley N° 28010, Ley General de Vacunas, declara que las actividades de vacunación son obligatorias para la salud pública nacional por su elevado impacto en la prevención y control de las enfermedades prevenibles por vacunación; y señala que el Ministerio de Salud, en su calidad de ente rector, es el responsable de establecer la sectorización y el calendario de vacunación, así como de vigilar su cumplimiento;

Que, el numeral 1) del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1161, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, establece que el Ministerio de Salud es competente en salud de las personas; y su artículo 4 dispone que el Sector Salud está conformado por el Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades adscritas a él, las instituciones públicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y las personas naturales que realizan actividades vinculadas a las competencias establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o indirecto en la salud, individual o colectiva;

Que, los literales b) y h) del artículo 5 del acotado Decreto Legislativo señalan que son funciones rectoras del Ministerio de Salud formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de las enfermedades, recuperación, rehabilitación en salud, tecnologías en salud y buenas prácticas en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; así como, dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de la política nacional y políticas sectoriales de salud, entre otras;

L. ROJAS

V. ALARCON G.

J. DEJOS

C. LINARES

Que, el artículo 63 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, refiere que la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública es el órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente del Viceministerio de Salud Pública, competente para dirigir y coordinar las intervenciones estratégicas de salud pública en materia de inmunizaciones, entre otras;

Que, según lo dispuesto en el literal b) del artículo 72 del mencionado Reglamento, la Dirección de Inmunizaciones de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública tiene la función de formular e implementar las políticas, normas, lineamientos y otros documentos en materia de intervenciones estratégicas a su cargo, en todas las etapas de vida, en coordinación con los Gobiernos Regionales;

Que, mediante los documentos del visto, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, a través de la Dirección de Inmunizaciones, propone la aprobación de la Norma Técnica de Salud que establece la vacunación contra el virus del dengue (tetravalente) en regiones priorizadas, cuya finalidad es contribuir a disminuir la morbi-mortalidad causada por dengue, protegiendo la vida y salud de la población a través de la vacunación;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública;

Con el visado de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, de la Secretaría General y del Despacho Viceministerial de Salud Pública; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1161, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la NTS N° 243 -MINSA/DGIESP-2026 "Norma Técnica de Salud que establece la vacunación contra el virus del dengue (tetravalente) en regiones priorizadas", que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo en la sede digital del Ministerio de Salud (www.gob.pe/minsa), en la misma fecha de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS NAPOLEÓN QUIROZ AVILÉS
Ministro de Salud

NTS N° 243 -MINSA/DGIESP-2026

NORMA TÉCNICA DE SALUD QUE ESTABLECE LA VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL DENGUE (TETRAVALENTE) EN REGIONES PRIORIZADAS

I. FINALIDAD

Contribuir a disminuir la morbi-mortalidad causada por dengue, protegiendo la vida y salud de la población a través de la vacunación.

II. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL:

Establecer disposiciones técnicas para las intervenciones de vacunación contra el dengue en el territorio peruano, priorizando las regiones de acuerdo al nivel de riesgo.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a) Definir las pautas técnicas y operativas para la vacunación contra el dengue en la población en riesgo.
b) Establecer las pautas administrativas para los trabajadores de salud de las instituciones del Ministerio de Salud (MINSA), en la programación, ejecución, evaluación, supervisión y coordinación de las acciones relativas a la vacunación contra el dengue.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Norma Técnica de Salud es de aplicación y cumplimiento para el Ministerio de Salud (MINSA), sus órganos desconcentrados y unidades orgánicas; así como para los establecimientos de salud de las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA), Gerencias Regionales de Salud (GERESA) y Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) de Lima Metropolitana.

IV. BASE LEGAL

- Ley N° 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias.
- Ley N° 28010, Ley General de Vacunas.
- Decreto Supremo N° 007-2014-SA, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1156, que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones, y sus modificatorias.
- Resolución Ministerial N° 063-2014/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 054-MINSA/DGE-V.01 "Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización (ESAVI)".
- Resolución Ministerial N° 884-2022/MINSA, que aprueba la NTS N° 196-MINSA/DGIESP-2022 "Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación", y sus modificatorias.

- Resolución Ministerial N° 074-2026/MINSA, que aprueba la NTS N° 242-MINSA/DGIESP-2026 "Norma Técnica de Salud para el Manejo de la Cadena de Frío en Inmunizaciones.
- Resolución Directoral N° 001-2021-DIGEMID-DG-MINSA, que aprueba el Formato de Notificación de Eventos supuestamente atribuidos a la Vacunación e Inmunización (ESAVI).

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. DEFINICIONES OPERATIVAS:

a) **Brigada de vacunación:** Equipo conformado por un vacunador (profesional de enfermería o técnico de enfermería capacitado) y un anotador (profesional de enfermería, técnico de enfermería capacitado u otro profesional).

b) **Cadena de frío:** Conjunto de procedimientos y actividades necesarios para garantizar las condiciones de temperatura requeridas que aseguren la potencia inmunológica de las vacunas desde su fabricación hasta su aplicación.

c) **Consentimiento informado:** Conformidad expresa de la persona vacunada. En caso se trate de un menor de edad, lo firma el padre, madre o tutor. Esta acción afirma que ha recibido la vacuna en forma libre, voluntaria y consciente, después de haber sido informado sobre la vacuna, incluyendo los riesgos reales/potenciales, efectos colaterales, efectos adversos, así como los beneficios. Debe ser registrado y firmado en un documento por la persona vacunada, el padre, madre o tutor, según corresponda, y el profesional responsable de la atención.

d) **Contraindicaciones:** Es una situación o prescripción específica por la cual no debe administrarse una vacuna.

e) **Dengue:** Es una enfermedad vírica que se transmite al ser humano por la picadura de mosquitos infectados, típicamente en climas tropicales y subtropicales de todo el mundo, sobre todo en las zonas urbanas y semiurbanas.

f) **Evento supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización (ESAVI):** Cualquier evento adverso asociado a la vacunación o inmunización que tiene una asociación temporal y no necesariamente causal. Se clasifica en leve, moderado y severo.

g) **ESAVI no severo (leves y moderados):** Evento que no pone en riesgo la vida de la persona, pero tiene una consecuencia en ella.

h) **ESAVI severo o grave:** Evento que incluye uno o más de los siguientes criterios: hospitalización, riesgo de muerte, discapacidad y/o fallecimiento.

i) **Inmunización:** Proceso por el que una persona se hace inmune o resistente a una enfermedad infecciosa, mediante la administración de una vacuna.

j) **Vacuna:** Es toda preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando una respuesta inmune específica contra la enfermedad infecciosa respectiva. Habitualmente es la suspensión de microorganismos virales, bacterianos vivos, inactivados o sus fracciones, subunidades o partículas proteicas de los mismos.

k) **Vacuna contra el dengue:** Es una vacuna tetravalente viva, atenuada, que contiene cuatro cepas del virus del dengue: una cepa atenuada del serotipo 2 caracterizada molecularmente (TDV-2) y cepas recombinantes de los serotipos 2/1 (TDV-1), 2/3 (TDV-3), y 2/4 (TDV-4).

l) **Vacunas vivas atenuadas:** Vacunas compuestas por microorganismos infecciosos vivos (bacterias o virus) que muestran bajos niveles de virulencia. Conservan la capacidad inmunogénica y estimulan la inmunidad protectora, pero han perdido el poder patógeno y muy rara vez son capaces de causar formas graves de enfermedad.

m) **Vacunación:** Acción que consiste en administrar una o una serie de vacunas a una persona, según edad y número de dosis, de acuerdo al esquema nacional de vacunación vigente.

n) **Vacunación segura:** Es un componente prioritario y esencial de los programas de inmunización y comprende el cumplimiento de un conjunto de procedimientos normalizados, estandarizados o protocolizados que se observan desde la formulación de una vacuna, su producción, transporte, almacenamiento y conservación, distribución, manipulación, reconstitución, administración (inyección segura), eliminación (bioseguridad) y la vigilancia epidemiológica e investigación de los ESAVI.

o) **Vacunatorio:** Espacio físico exclusivo dentro o fuera de los establecimientos de salud públicos o privados, donde se realizan las actividades de orientación, consejería y administración de vacunas por un profesional de enfermería, debidamente capacitado para la atención de las personas.

5.2. Las actividades de vacunación programadas deben ser lideradas por los directores regionales y jefes de los establecimientos de salud en el ámbito que les corresponde.

5.3. El comité técnico de cada GERESA, DIRESA y DIRIS de Lima Metropolitana, se organiza según sus competencias funcionales y técnicas para la aplicación, operatividad y cumplimiento de la presente Norma Técnica de Salud.

5.4. La vacuna contra el dengue no será administrada en forma simultánea con otras vacunas o cuando exista el antecedente de vacunación en los últimos treinta (30) días.

5.5. La Dirección de Inmunizaciones de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP) del MINSA, en coordinación con la Dirección General del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), determinan la población objetivo de intervención de acuerdo a la situación epidemiológica, para salvaguardar la salud y la vida de la población.

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1. MEDIDA DE PREVENCIÓN O PROTECCIÓN ESPECÍFICA

Siendo la vacunación la principal medida de prevención contra el virus del dengue, se implementan acciones de forma gradual, según la disponibilidad de vacunas, priorizando regiones de acuerdo a la situación epidemiológica actual (incremento de casos de dengue).

La vacunación se realiza según los siguientes grupos de prioridad:

- Población de 10 a 20 años de edad que reside en zonas de riesgo.

- Profesional de salud hasta los 59 años de edad que labora en zonas de riesgo de exposición al dengue.
- Toda persona hasta los 59 años de edad que presta servicio militar en zonas de riesgo de exposición al dengue.
- Otra población que considere la Autoridad Nacional de Salud.

6.2. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EN LA VACUNACIÓN

La estrategia de vacunación para la prevención del virus del dengue se realiza a través de intervenciones intramurales y extramurales, considerando el siguiente detalle:

6.2.1 Intramural:

- Vacunación en los establecimientos de salud priorizados del territorio peruano, de acuerdo a la situación epidemiológica y disponibilidad de vacuna.
- Otras estrategias regionales.

6.2.2 Extramural:

Se realiza en diversos escenarios fuera de los establecimientos de salud, a través de la implementación de un puesto fijo o móvil y dependerá de la realidad epidemiológica, demográfica y sociocultural de cada lugar.

- **Vacunación en Puestos fijos**, identificados y ubicados estratégicamente: mercados, locales comunales, centros educativos, lozas deportivas, entre otros.
- **Vacunación en Puestos móviles**, se considera a las brigadas de vacunación que se desplazan por las calles, sectores y comunidades para el seguimiento y captación de la población objetivo a vacunar o a través de las visitas casa por casa.

Estos espacios de vacunación deben garantizar condiciones de bioseguridad con flujo adecuado de la circulación de la población objetivo.

6.3. PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS

La Dirección de Inmunizaciones (DMUNI) de la DGIESP realiza el requerimiento de vacunas e insumos teniendo en cuenta las especificaciones técnicas según necesidad al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES).

Los criterios de programación para la adquisición de vacunas son definidos por la DMUNI en base a la situación epidemiológica y elabora el cuadro de distribución, el cual es remitido al CENARES para la atención a las GERESA/DIRESA/DIRIS de Lima Metropolitana.

El CENARES, según su competencia, realiza la adquisición y distribución de vacunas, jeringas y otros insumos necesarios para la vacunación a las GERESA/DIRESA/DIRIS de Lima Metropolitana.

En el nivel regional, el responsable de cadena de frío, en coordinación con el responsable de Medicamentos, Insumos y Drogas, son los responsables de la

recepción, almacenamiento y distribución de las vacunas a los niveles regionales, en cumplimiento al marco normativo vigente.

6.4. PERSONAL QUE ADMINISTRA LA VACUNA

La vacunación contra el virus del dengue está a cargo del personal profesional de enfermería, en casos excepcionales donde no se cuente con este profesional, vacunará el personal técnico de enfermería capacitado.

La GERESA/DIRESA y DIRIS de Lima Metropolitana, garantiza la capacitación al personal que realiza las acciones de vacunación contra el dengue.

6.5. SISTEMA DE INFORMACIÓN

La Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) del MINSA remite a la DMUNI la población estimada según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), y el CDC determina la población a vacunar contra el virus del dengue, en función a los criterios epidemiológicos.

Los puntos de vacunación para la actividad de vacunación contra el virus del dengue, deben registrarse en el **Módulo Actividades Complementarias del HISMINSA / Módulo de inmunizaciones del SIHCE** en la actividad "PILOTO: VACUNA CONTRA EL DENGUE".

6.6. INTERVENCIÓN POR NIVELES DE ATENCIÓN

DGIESP/DMUNI

- El Estado Peruano, a través del MINSA, garantiza la provisión de vacunas y jeringas para el cumplimiento de la presente Norma Técnica de Salud.
- Asegura la capacitación sobre la implementación de la presente Norma Técnica de Salud.
- Garantiza la gratuidad de la vacunación.
- Brinda asistencia técnica permanente a los niveles regionales.
- Monitoriza, supervisa y evalúa las acciones realizadas en cada nivel regional y local.

GERESA/DIRESA/DIRIS

- Las GERESA, DIRESA y DIRIS garantizan los recursos humanos, materiales, insumos y gastos operativos para la implementación de la presente Norma Técnica de Salud.
- Garantizan la distribución, transporte y el uso eficiente de las vacunas y de todos los insumos necesarios para la vacunación en el ámbito de su jurisdicción.
- Monitoriza la implementación de la presente Norma Técnica de Salud.
- Garantiza la gratuidad de la vacunación en los puntos de vacunación.
- Planifican, organizan e implementan la vacunación.
- Monitorea el cumplimiento de transporte, almacenamiento y manipulación de la vacuna según la normativa vigente sobre cadena de frío.
- Garantizan la capacitación al personal de salud: Vacunador y anotador.
- Monitoriza, supervisa y evalúa las acciones realizadas en el nivel local.

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Los establecimientos de salud de la GERESA, DIRESA y DIRIS de Lima Metropolitana, deben tener en cuenta lo siguiente:

- Asegura el material necesario para el procedimiento de la vacunación contra el dengue.
- Cumple con las especificaciones técnicas de cadena de frío.
- El personal de enfermería que administra la vacuna contra el dengue, debe aplicar el proceso de vacunación segura, asegurando el procedimiento correcto.
- El profesional de enfermería (vacunador) debe realizar el registro de los vacunados en el aplicativo (HISMINSA – SIHCE), control de calidad de datos de los formatos en físico y registro digital.
- Las actividades de vacunación deben regirse bajo el cumplimiento estricto de la presente Norma Técnica de Salud y de la normativa vigente sobre el manejo de cadena de frío en las inmunizaciones.
- En caso de presentarse un ESAVI Severo debe cumplirse con la notificación respectiva y la atención inmediata, según corresponda, en un establecimiento de salud con la capacidad resolutiva necesaria.
- Los ESAVI no severos deben ser notificados por el personal de salud o en el auto reporte de farmacovigilancia a cargo de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID). Debe anexarse la Ficha de Investigación Clínico Epidemiológica de ESAVI severo, según la Directiva Sanitaria N° 054-MINSA/DGE-V.01 "Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización (ESAVI)", o la que haga sus veces.
- Los casos de ESAVI no severo (leve o moderado) deben ser notificados por el personal de salud en el formato de notificación de Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización a cargo de la DIGEMID, según el Anexo N° 09.

6.7. COMPONENTES DE GESTIÓN

6.7.1. COMPONENTE DE ASESORAMIENTO

La DMUNI cuenta con un Comité de Expertos, que brinda asesoramiento respecto a la vacunación en todas las etapas de vida. Entre sus funciones se encuentran:

- Brindar recomendaciones basadas en evidencia científica respecto a la introducción de nuevas vacunas, considerando las prioridades nacionales de salud pública, así como los criterios técnicos programáticos, logísticos y financieros existentes.
- Emitir opinión sobre el calendario nacional de vacunación, incluidos los esquemas y tipos de vacunas, así como las especificaciones técnicas para su mejor uso.
- Colaborar con las estrategias diseñadas para brindar seguridad a las vacunas incluidas en el calendario nacional.
- Proponer mejoras en las políticas sanitarias de inmunizaciones, con particular énfasis en los sistemas de información que permitan monitorear y evaluar las coberturas de vacunación y la calidad de los servicios brindados.

- Proponer estrategias de vigilancia y protocolos para notificación de enfermedades prevenibles por vacunación.
- Asesorar sobre los adelantos en el desarrollo de nuevas vacunas y el potencial para la inclusión en el calendario nacional de inmunizaciones, así como en las estrategias para la investigación y desarrollo de nuevas vacunas y las tecnologías de administración de vacunas.

6.7.2. COMPONENTE DE ATENCIÓN

a) Ambiente 1 – Sala de espera

El personal de salud:

- Solicita el Documento Nacional de Identidad (DNI) para verificar la identidad y edad del usuario.
- Sensibiliza a la población objetivo a vacunar e informa sobre la importancia de la vacuna contra el dengue.

b) Ambiente 2 – Vacunatorio

El Licenciado en Enfermería o Técnico de Enfermería capacitado:

- Adecúa los paquetes fríos y prepara correctamente el termo porta vacunas.
- Asegura el material necesario de la vacunación.
- Informa a la persona sobre el proceso de vacunación.
- Entrega el formato de consentimiento informado para su lectura, llenado correcto y firma del mismo.
- Realiza preguntas claves antes de proceder con la administración de la vacuna, de acuerdo a lo señalado en el Anexo N° 05.
- Verifica el estado vacunal, dosis que le corresponde según ficha técnica de la vacuna.
- Prepara la vacuna según indicaciones técnicas.
- Administra la vacuna contra el dengue, aplicando los procedimientos correctos de inyección segura.

c) Ambiente 3 – Área de reposo

- Inmediatamente luego de la vacunación, la persona debe pasar al área de reposo por 30 minutos, a fin de monitorear y detectar oportunamente algún caso de ESAVI para el tratamiento inmediato, el mismo que debe ser notificado.
- El personal de salud orienta y brinda consejería post vacunación, sobre los posibles efectos adversos de la vacuna contra el dengue y qué medidas aplicar.

6.8. MANEJO DE LA VACUNA CONTRA EL DENGUE

El Licenciado de Enfermería o Técnico de Enfermería capacitado realiza las siguientes acciones:

6.8.1. ANTES DE LA VACUNACIÓN

- Registro diario de temperatura del refrigerador (conservación de la vacuna).
- Adecuación de la temperatura de los paquetes fríos de los termos manteniendo temperaturas de +2 a +8°C.
- Asegura el orden y limpieza del ambiente de vacunas (punto de vacunación).
- Prepara el material (termos, jeringas, jabón líquido, entre otros insumos).
- Revisa las vacunas (verificar fecha de vencimiento y lote).
- Conoce la dosis, vía de administración y jeringa a utilizar.
- Lee el inserto de la vacuna.
- Revisa el kit de ESAVI, según la NTS N° 196-MINSA/DGIESP-2022 "Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación" (1 ampolla de Epinefrina 1mg/1ml, 1 frasco de ampolla de hidrocortisona succinato sódico 100mg, 1 ampolla de clorfenamina 10mg/1 ml, 1 ampolla de agua destilada, 1 jeringa de 1 ml y 1 aguja de 25G x 5/8).
- El vacunador debe realizar preguntas claves antes de proceder con la administración de la vacuna, de acuerdo a lo señalado en el Anexo N° 05.
- Si procede la vacunación, el vacunador solicita el consentimiento informado. En caso este sea menor de edad, debe firmar el padre, madre o apoderado.
- Identifica a la persona a vacunar y realiza la verificación de la condición vacunal a través del HISMINSA/SIHCE módulo de inmunizaciones.

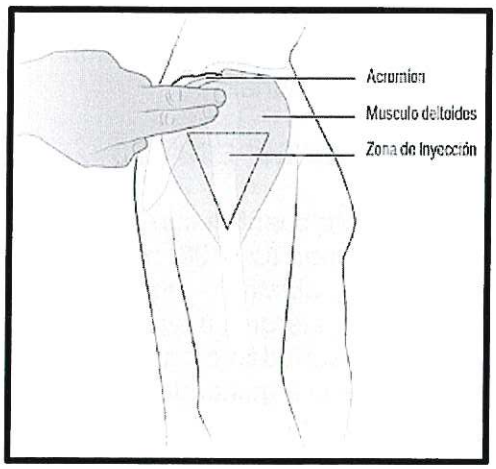
6.8.2. DURANTE LA VACUNACIÓN

- Indica a la persona a vacunarse que espere sentado y tranquilo.
- Procede con lavado de manos.
- Se debe considerar el esquema de vacunación, según descripción de la vacuna detallada en Anexo N° 01.
- Se realiza la reconstitución de la vacuna, según los procedimientos detallados en el Anexo N° 02.

6.8.3. ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA

- Explica a la persona a vacunar el tipo de vacuna, dosis, vía de administración y posibles efectos adversos, generando un ambiente de confianza.
- Luego procede a limpiar el sitio de aplicación de la vacuna, utilizando jabón líquido o clorhexidina al 0,05% con movimiento circular del centro hacia afuera.
- No usar torundas de algodón previamente humedecidas y guardadas en tambores u otros recipientes.
- Levanta la piel del músculo deltoides y calcular el grosor del tejido celular subcutáneo.
- Introduce la aguja de la jeringa de 1ml con el bisel hacia arriba en la parte superior de la cara lateral externa del brazo (tercio medio del músculo deltoides), de manera que la solución de la vacuna se sitúe exactamente en el tejido celular subcutáneo en un ángulo de 45°.
- Administra lentamente la vacuna.
- Al terminar de inyectar la vacuna, retire la aguja siguiendo el ángulo de introducción para evitar daño al tejido.

- Realiza presión suave con algodón en el lugar de la administración de la vacuna.



MÚSCULO DELTOIDES

6.8.4. DESPUÉS DE LA VACUNACIÓN

- Deseche la jeringa en la caja de bioseguridad.
- Explica a la persona que evite frotarse, que no realice presión excesiva y no colocar ninguna sustancia en el sitio de aplicación.
- Registra en el carné el lote, la fecha que se administra la vacuna y la fecha de la 2da dosis, indicando que es indispensable que presente el carné de vacunación en la fecha que se va a aplicar la segunda dosis. Ver Anexo N° 08.
- Reforzar la importancia de la aplicación de la segunda dosis de la vacunación.
- Indica a la persona vacunada que se traslade al área de reposo (ambiente N° 3), donde debe permanecer sentada por lo menos treinta (30) minutos para tenerla en observación, con la finalidad de monitorear, identificar y tratar inmediatamente algún posible evento adverso.
- En caso de presentar un ESAVI, la atención debe ser realizada de manera inmediata por el médico y equipo multidisciplinario en el tópico del establecimiento de salud y, en caso de requerirse, se debe realizar la referencia al establecimiento de salud de mayor complejidad. Asimismo, debe cumplirse con la notificación respectiva.
- Los ESAVI leves y moderados se notifican utilizando el formato detallado en el Anexo N° 09 y siguiendo el flujograma detallado en el Anexo N° 10.
- Los ESAVI severos son de notificación inmediata, usando la vía de comunicación más rápida al nivel inmediato superior, incluyendo los datos contenidos en la Ficha detallada en el Anexo N° 11.
- De no presentar signos o síntomas que ameriten mayor tiempo de observación, indicar que se retire a su domicilio, previo reforzamiento de información sobre posibles reacciones adversas y conducta a seguir.
- Recomendar a la persona vacunada, en el caso de presentar reacciones post vacunales estando en su domicilio que ameriten atención médica, acudir al establecimiento de salud más cercano para recibir una atención inmediata y luego la notificación del caso según corresponda.

6.8.5. ESQUEMA DE VACUNACIÓN

El esquema de vacunación contra el dengue considera la administración de dos (02) dosis con un intervalo de tres (03) meses en la población objetivo de las regiones que inicia la intervención según situación epidemiológica y disponibilidad de la vacuna.

6.8.6. CONSIDERACIONES ESPECIALES

- Las personas que cuentan con un resultado positivo de la enfermedad del dengue, se vacunan seis (06) meses después de la exposición.
- La población objetivo que reciba tratamiento inmunosupresor (quimioterapias), alérgica a algún medicamento, alimento, con diagnóstico de VIH, con enfermedad crónica (Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial) o que se encuentre gestando o en periodo de lactancia, entre otros, no podrá recibir la vacuna contra el dengue.

6.9. MANEJO DE RIESGOS EN LAS VACUNAS

6.9.1. SEGURIDAD DE VACUNAS Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LOS EVENTOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIDOS A LA VACUNACIÓN O INMUNIZACIÓN (ESAVI)

En la actualidad, las vacunas son más seguras que hace 40 años, su fabricación, control y reglamentación, exigen conocimientos y procedimientos especiales considerando que, por lo general, son administradas en personas sanas y primordialmente a la población infantil, observándose comúnmente manifestaciones clínicas leves y transitorias y, en muy raras veces, cuadros graves.

Los síntomas, signos o resultados anormales de laboratorio de enfermedades coexistentes pueden conllevar a confusión con reacciones post vacunales generando dudas de su seguridad y hasta en ocasiones llevando a la crisis con la interrupción de campañas. Los eventos adversos de interés especial (EVADIE) y los eventos severos ameritan de una atención preferente en los establecimientos de salud, cuyo manejo debe ser de acuerdo a la impresión diagnóstica, se debe comunicar a epidemiología para su notificación inmediata, según lo establecido en la Directiva Sanitaria N° 054-MINSA/DGE-V.01 "Directiva Sanitaria para la vigilancia epidemiológica de eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización (ESAVI)", estando a cargo del CDC-MINSA.

Durante campañas masivas de vacunación o incorporación de nuevas vacunas al Esquema Nacional de Vacunación, se activa el sistema de vigilancia de ESAVI, vigilancia intensificada consistente en el reporte diario de presencia o ausencia de caso ESAVI por los establecimientos de salud al CDC-MINSA. Los cuadros severos ameritan investigación individual minuciosa según la normativa, mientras que los conglomerados no graves también deben ser investigados; tanto la notificación como los flujos de información deben seguir las pautas establecidas en la normatividad vigente y lineamientos proporcionados por el CDC-MINSA.

Los ESAVI leves y moderados deben ser reportados al Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia (Cenafyt) de la DIGEMID, a través del

formato físico, según lo establecido en la Resolución Directoral N° 001-2021-DIGEMID-DG-MINSA y de acuerdo a sus modificaciones, o a través de los medios electrónicos, como el VigiFlow o eReporting, según corresponda.

6.10. GESTIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE VACUNACIÓN CONTRA EL DENGUE

La gestión y manejo de residuos sólidos se enmarcan en la NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA Norma Técnica de Salud: "Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud, Servicios Médicos de Apoyo y Centros de Investigación", aprobada por Resolución Ministerial N° 1295-2018/MINSA, donde se detallan las etapas del manejo de residuos sólidos, entre ellas: acondicionamiento, segregación, almacenamiento primario, recolección y transporte interno, almacenamiento central o final, recolección y transporte externo, y disposición final de los residuos sólidos.

La DIRESA/GERESA y DIRIS de Lima Metropolitana, son responsables de su cumplimiento, través del área de salud ambiental o la que haga sus veces.

VII. RESPONSABILIDADES

7.1. NIVEL NACIONAL

La Dirección de Inmunizaciones de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud, es responsable de difundir la presente Norma Técnica de Salud, hasta el nivel regional, así como de brindar asistencia técnica, capacitar, monitorear, supervisar y evaluar su cumplimiento.

7.2. NIVEL REGIONAL

La GERESA / DIRESA / DIRIS son responsables de difundir, brindar asistencia técnica, implementar y hacer cumplir lo establecido en la presente Norma Técnica de Salud en su respectivo ámbito o jurisdicción, así como de monitorear, supervisar y evaluar su cumplimiento.

7.3. NIVEL LOCAL

Los establecimientos de salud comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Norma Técnica de Salud son responsables de su cumplimiento en lo que corresponda.

VIII. DISPOSICIÓN FINAL

Los aspectos no contemplados en la presente Norma Técnica de Salud son resueltos o dispuestos por la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Inmunizaciones.

IX. ANEXOS

- **ANEXO N° 01:** DESCRIPCIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL DENGUE.
- **ANEXO N° 02:** RECONSTITUCIÓN DE LA VACUNA.

- **ANEXO N° 03:** FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN.
- **ANEXO N° 04 - A:** CONSENTIMIENTO INFORMADO EN EL MENOR DE EDAD.
- **ANEXO N° 04 - B:** CONSENTIMIENTO INFORMADO EN EL MAYOR DE EDAD.
- **ANEXO N° 05:** PREGUNTAS CLAVES PREVIO A LA VACUNACIÓN.
- **ANEXO N° 06:** ACTA DE APERTURA DE LA JORNADA DIARIA DE VACUNACIÓN.
- **ANEXO N° 07:** ACTA DE CIERRE DE LA JORNADA DIARIA DE VACUNACIÓN.
- **ANEXO N° 08:** CARNÉ DE VACUNACIÓN.
- **ANEXO N° 09:** FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE ESAVI LEVE O MODERADO.
- **ANEXO N° 10:** FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS U OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (SRAM) O ESAVI LEVE Y MODERADO PARA PROFESIONALES DE LA SALUD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SIN INTERNAMIENTO.
- **ANEXO N° 11:** FICHA DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE ESAVI SEVERO.
- **ANEXO N° 12:** FORMATO DE REGISTRO INDIVIDUAL DE VACUNACIÓN CONTRA DENGUE.
- **ANEXO N° 13:** FORMATO DE REGISTRO CONSOLIDADO DE VACUNACIÓN CONTRA DENGUE.
- **ANEXO N° 14:** MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS POR LA VACUNACIÓN.

ANEXO N° 01
DESCRIPCIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL DENGUE

TIPO DE VACUNA	Tetravalente contra el Dengue.
DESCRIPCIÓN	Vacuna viva atenuada recombinante y quimérica basada en DENV-2, al que se le ha añadido material genómico que expresa los antígenos de DENV-1, DENV-3, y DENV-4.
COMPOSICIÓN **CUALITATIVA - CUANTITATIVA**	**Tras la reconstitución, 1 dosis (0,5 ml) contiene:** Serotipo 1 del virus del dengue (vivo, atenuado) *≥ 3,3 log10 UFP**/dosis. Serotipo 2 del virus del dengue (vivo, atenuado) #≥ 2,7 log10 UFP**/dosis. Serotipo 3 del virus del dengue (vivo, atenuado) *≥ 4,0 log10 UFP**/dosis. Serotipo 4 del virus del dengue (vivo, atenuado) *≥ 4,5 log10 UFP**/dosis. **Polvo:** α, α-Trehalosa; dihidrato; poloxámero 407; albúmina de suero humano; fosfato dihidrógeno de potasio; fosfato de hidrógeno disódico; cloruro de potasio y cloruro de sodio. **Diluyente:** Cloruro de sodio y agua para inyectable.
PRESENTACIÓN	Polvo y diluyente para solución inyectable en jeringa prellenada. Polvo (1 dosis) en vial de vidrio + 0,5 ml de diluyente en jeringa prellenada con 2 agujas separadas. Monodosis.
INDICACIÓN	Prevención de la enfermedad del Dengue en personas a partir de los 4 años de edad.
ESQUEMA DE VACUNACIÓN	Al primer contacto con el establecimiento de salud (0 meses). A los tres meses de la primea dosis (3 meses).
DOSIS	0.5 ml.
VIA Y SITIO DE ADMINISTRACIÓN	Subcutánea (SC), en la parte superior de la cara lateral externa del brazo (tercio medio del músculo deltoides).
CONSERVACIÓN DE LA VACUNA	+2 y +8 °C (No congelar). Una vez reconstituida, el tiempo de uso es de 2 horas.
JERINGAS A UTILIZAR	Para reconstituir: Jeringa descartable de 5 ml y aguja de 21G x 1 ½". Para administrar: jeringa de 1ml de 25G x 5/8", auto retráctil.
POSIBLES EFECTOS POST VACUNALES	Puede presentar dentro de los dos días posteriores: Dolor, enrojecimiento en el sitio de la aplicación, dolor muscular, dolor de cabeza, malestar general, fiebre y debilidad. Estas reacciones desaparecen en las siguientes veinticuatro (24) a setenta y dos (72) horas.
CONTRAINDICACIONES	Hipersensibilidad a los principios activos o a cualquiera de los excipientes o hipersensibilidad a una dosis previa de la vacuna contra el dengue. Las personas con inmunodeficiencia congénita o adquirida, incluidas las terapias inmunosupresoras como la quimioterapia o dosis altas de corticosteroides sistémicos. Personas con infección por virus de inmunodeficiencia humana (VIH) sintomática o con infección por VIH asintomática cuando se acompaña de evidencia de función inmunológica deteriorada. Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

PRECAUCIONES	Indagar sobre los antecedentes médicos de la persona a vacunar. El vacunador indaga si la persona a vacunar ha tenido dengue, si la respuesta es afirmativa, se debe tomar en cuenta que el tiempo para la administración de la vacuna debe ser de 6 meses. Se debe posponer la vacunación en personas que padezcan una enfermedad aguda moderada o grave con o sin fiebre. En casos de personas con enfermedades crónicas, evaluar cada caso según riesgo - beneficio. La vacuna se debe administrar con precaución en personas con trombocitopenia o con trastorno de la coagulación, ya que se puede producir una hemorragia tras la administración de la vacuna. Se recomienda postergar la vacunación por tres a once meses en pacientes con reciente administración de gammaglobulina, sangre y hemoderivados. Las reacciones relacionadas con la ansiedad, incluyendo reacciones vasovagales (síncope), hiperventilación o reacciones relacionadas con el estrés pueden ocurrir en asociación con la vacunación como una respuesta psicogénica a la inyección de aguja. Tomar precauciones para evitar lesiones por desmayos. Al igual que con otras vacunas vivas atenuadas, las mujeres en edad fértil deben evitar el embarazo durante al menos un mes después de la vacunación. La vacuna no debe administrarse mediante inyección intravascular, intradérmica o intramuscular en ninguna circunstancia. No existen datos sobre el uso de la vacuna contra el dengue en personas mayores a 60 años y los datos son limitados en pacientes con afecciones médicas crónicas.

*Producido en células vero mediante tecnología de ADN recombinante. Genes de las proteínas de superficie específicas del serotipo, insertados en la estructura genómica del dengue tipo 2.
#Producido en células vero mediante tecnología de ADN recombinante.
**UFP: unidades formadoras de placa.

MINISTERIO DE SALUD
V. ALARCON G

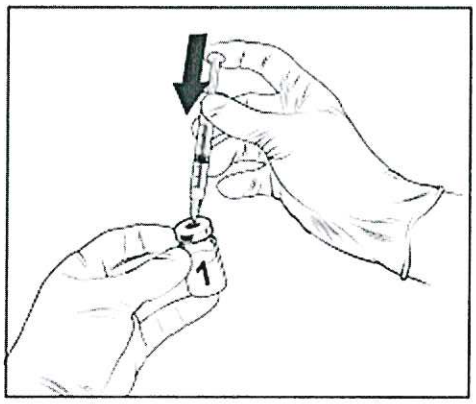
MINISTERIO DE SALUD - DGIESP
V°B°
DIRECTORA EJECUTIVA

ANEXO N° 02
RECONSTITUCIÓN DE LA VACUNA

Pasos para la reconstitución de la vacuna:

- Retirar el vial de la vacuna y el vial del diluyente del termo, colocarlos a temperatura ambiente y esperar 15 minutos para iniciar el proceso de reconstitución.
- Pasado los 15 minutos, proceder a realizar la reconstitución de la vacuna.
- Retire el vial de la vacuna y limpie la superficie del tapón de la parte superior del vial con algodón con alcohol.
- Diluir el frasco de vacuna con el diluyente de 0.5 ml, con la jeringa y aguja descartable de 5 ml x 21G ½.
- Inserte la jeringa prellenada en el vial de la vacuna.
- Dirija el flujo del diluyente hacia el costado del vial mientras presiona lentamente el embolo, para reducir la posibilidad de que se formen burbujas.

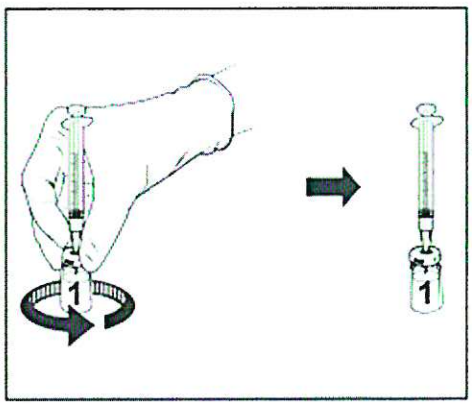
1



VIAL DE VACUNA LIOFILIZADA

- Haga girar suavemente el vial en ambas direcciones con la aguja y jeringa en una superficie plana.
- NO AGITE. Puede formarse espuma y burbujas en el producto reconstituido.

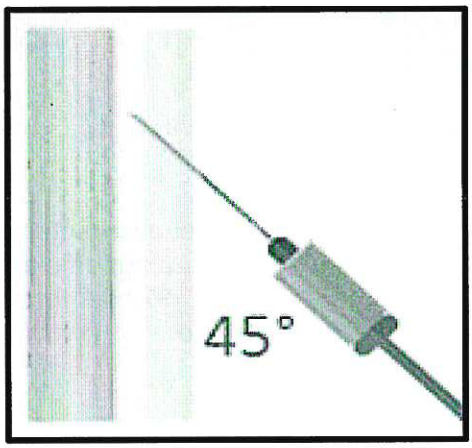
2



VACUNA RECONSTITUIDA

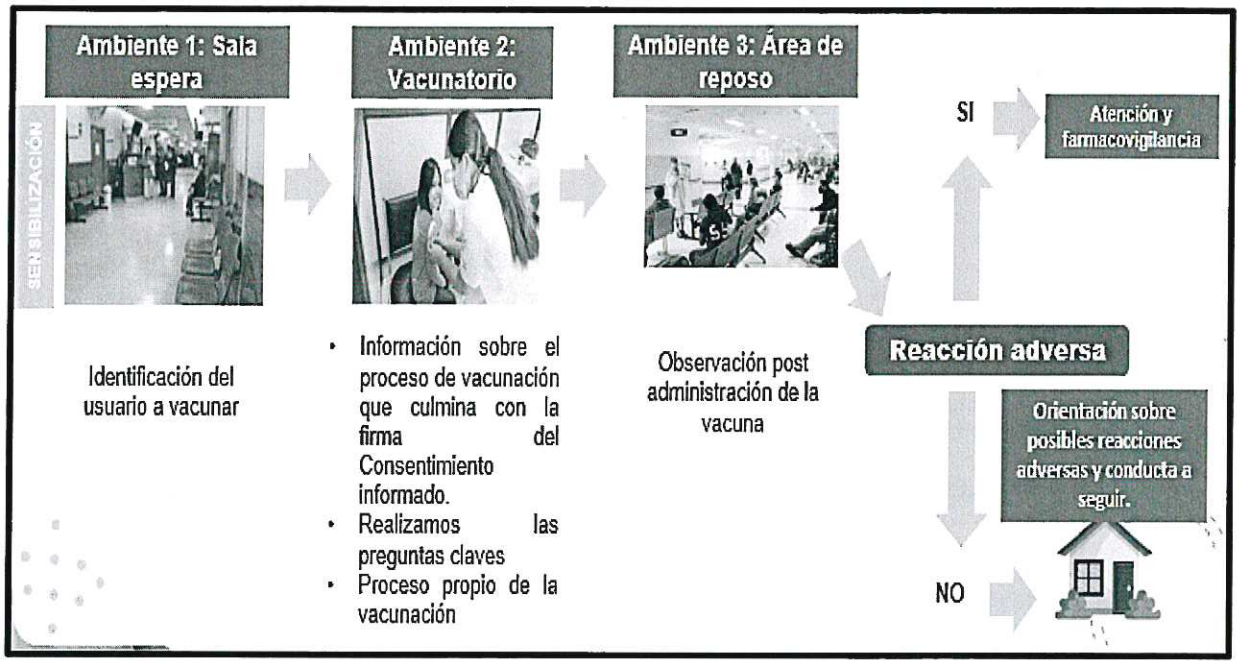
- Tras la reconstitución, la solución resultante debe ser transparente, incolora a amarillo pálido y libre de partículas extrañas. Deseche la vacuna si hay presencia de partículas y/o si cambió de color.
- Extraiga todo el volumen de la vacuna reconstituida, con la jeringa de 1ml x 25G 5/8, para su administración correspondiente.
- Sostenga la jeringa con el bisel de la aguja apuntando hacia arriba.
- La administración de la vacuna debe realizarse de forma inmediata una vez reconstituida la vacuna, para evitar errores programáticos o alterar la cadena de frío.
- La vía de administración es vía subcutánea (ángulo 45°), en la parte superior de la cara lateral externa del brazo (tercio medio del músculo deltoides).

3



VIA SUBCUTANEA

ANEXO N° 03
FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN



ANEXO N° 04 - A
CONSENTIMIENTO INFORMADO EN EL MENOR DE EDAD

PERÚ Ministerio de Salud

Yo me vacuno contra el dengue

CONSENTIMIENTO INFORMADO
VACUNACIÓN CONTRA EL DENGUE – 202_

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de un zancudo infectado, llamado Aedes Aegypti.

La vacunación contra el Dengue es una medida preventiva para evitar atención hospitalaria o la enfermedad grave.

POSIBLES REACCIONES DESPUES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA:

Puede presentar dentro de los dos días posteriores a administración de la vacuna: dolor, enrojecimiento en el sitio de la aplicación, dolor muscular, dolor de cabeza, malestar general, fiebre y debilidad. Estas reacciones desaparecen en las siguientes veinticuatro (24) a setenta y dos (72) horas; si persisten o se presentan otras reacciones, acudir a un establecimiento de salud más cercano a su domicilio o llamar al 113.

Se vacunará gratuitamente a las niñas, niños y adolescentes, desde los diez (10) años hasta los diecisiete (17) años, (11) meses, veintinueve (29) días, con (02) dos dosis con un intervalo de (03) tres meses.

DECLARACIÓN:

Yo, ..., identificado(a) con DNI N° ....., Padre, Madre o apoderado(a) de ....., identificado(a) con DNI N°....., dejo constancia de haber sido informado sobre los beneficios y posibles reacciones de la administración de la vacuna contra el dengue.

Por lo tanto: Autorizo al personal de salud la vacunación contra el dengue a mi menor hijo(a).

Fecha:

Firma y sello del vacunador	Firma padre/madre o apoderado	Huella

MINISTERIO DE SALUD DIGESP V°B° DIRECTORA EJECUTIVA

ANEXO N° 04 - B
CONSENTIMIENTO INFORMADO EN EL MAYOR DE EDAD

PERÚ | Ministerio de Salud

Yo me vacuno contra el dengue

CONSENTIMIENTO INFORMADO
VACUNACIÓN CONTRA EL DENGUE – 202_

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de un zancudo infectado, llamado Aedes Aegypti.

La vacunación contra el Dengue es una medida preventiva para evitar atención hospitalaria o la enfermedad grave.

POSIBLES REACCIONES DESPUES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA:

Puede presentar dentro de los dos días posteriores a administración de la vacuna: dolor, enrojecimiento en el sitio de la aplicación, dolor muscular, dolor de cabeza, malestar general, fiebre y debilidad. Estas reacciones desaparecen en las siguientes veinticuatro (24) a setenta y dos (72) horas; si persisten o se presentan otras reacciones, acudir a un establecimiento de salud más cercano a su domicilio o llamar al 113.

Se vacunará gratuitamente a toda persona hasta los cincuenta y nueve (59) años, (11) meses, veintinueve (29) días, con (02) dos dosis con un intervalo de (03) tres meses.

DECLARACIÓN:

Yo, ..., identificado(a) con DNI N° ....., he sido informado sobre los beneficios y posibles reacciones de la administración de la vacuna contra el dengue.

Por lo tanto: Autorizo al personal de salud la vacunación contra el dengue a mi persona.

MINISTERIO DE SALUD D.G. V. ALARCON G.

Fecha:

MINISTERIO DE SALUD / DGIESP DIRECTIVA EJECUTIVA V°B°

Firma y sello del vacunador	Firma padre/madre o apoderado	Huella

ANEXO N° 05
PREGUNTAS CLAVES PREVIO A LA VACUNACIÓN

Nº	Criterios	Sí	No	Observación
1	Edad de 10 a 59 años, 11 meses y 29 días.			
2	Residencia mayor a 30 días en el distrito priorizado.			
3	¿Ha tenido sospecha o diagnóstico de dengue en los últimos 6 meses?			Detallar en qué mes:
4	Ha autorizado el consentimiento informado (mayor de 18 años) / El padre, madre o tutor firmó el consentimiento informado (menor de edad).			
5	Es alérgico a algún medicamento, alimento.			Detallar:
6	Ha tenido reacción a alguna vacuna.			Detallar:
7	Recibió primera dosis y tuvo reacciones adversas.			Detallar las reacciones:
8	Recibe tratamiento inmunosupresor (quimioterapia, dosis altas de corticoides sistémicos) en las 4 semanas antes de la vacunación.			¿Cuál o por qué?
9	Es una persona con inmunodeficiencia congénita (ejemplo: pacientes con síndrome Down, entre otros) o adquirida.			
10	Es una persona con diagnóstico de VIH.			
11	Actualmente está embarazada o en periodo de lactancia.			
12	Actualmente cursa con una enfermedad aguda moderada o grave con o sin fiebre.			
13	Tiene alguna enfermedad crónica (ejemplo: Diabetes Mellitus tipo I, entre otros).			Detallar:
14	Ha sufrido de moretones, hematomas, petequias en la piel, y o sangrados frecuentes (nasal, encías, entre otros).			
15	Recibe tratamiento con inmunoglobulinas o hemoderivados (sangre, plasma).			

*Si la respuesta a la pegunta 3 es Sí, se pospone la vacunación hasta cumplir los 6 meses, luego de la infección por dengue.
*Si la respuesta de la pregunta 4 es No, no se procederá a la vacunación.
Si al menos una de las respuestas es "SÍ", a partir de la pregunta 5 al 10, no procede la vacunación; y si al menos una de las respuestas es "SÍ" a partir de la pregunta 11 al 14, pasa a consulta médica para evaluación y decisión médica de la administración de la vacuna.

MINISTERIO DE SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA SANITARIA V.º B.º

MINISTERIO DE SALUD - DGIESP Dirección de Inmunizaciones Lic. Magdalena del Rosario Quispe Icaza V°B° DIRECTORA EJECUTIVA

ANEXO N° 06
ACTA DE APERTURA DE LA JORNADA DIARIA DE VACUNACIÓN

Siendo el día ..... de ..... del presente año, a las ..... horas, se dio inicio a la actividad de vacunación contra el dengue, recibiendo ..... vacunas e insumos para el proceso de vacunación ..... del distrito de ..... de la provincia de ..... del departamento de .....

Con la presencia de la responsable de inmunizaciones del EE. SS. y la monitora, se da conformidad a la cantidad de vacunas recibidas de acuerdo a la meta programada para el día de hoy.

Hora de entrega:

Meta:

Cantidad de dosis de vacunas recibida:

Lote de vacuna:

Fecha de expiración:

Firmando los involucrados en señal de conformidad

Apellidos y Nombres:	Apellidos y Nombres:
Coordinador del EE. SS.	Monitor (a) de las brigadas

Apellidos y Nombres:

Enfermero (a) vacunador (a) de la brigada

ANEXO N° 07
ACTA DE CIERRE DE LA JORNADA DIARIA DE VACUNACIÓN

Siendo el día ..... de ..... del presente año, a las ..... horas, se procede al cierre de la actividad de vacunación contra el dengue realizado en ..... del distrito de..... de la provincia de ..... del departamento de.....

Con la presencia de la responsable de inmunizaciones del EE. SS., la monitora y vacunadora de la brigada, se procede a dejar constancia de lo siguiente:

Vacunas recibidas a la apertura de acta del día:

Vacunas utilizadas (dosis) en el día:

Saldo:

Lote de vacuna:

Fecha de expiración:

Reporte de incidencias:

En señal de conformidad, firman los presentes.

Apellidos y Nombres:	Apellidos y Nombres:
Coordinador del EE. SS.	Monitor(a) de las brigadas

Apellidos y Nombres:

Enfermero (a) vacunador (a) de la brigada

ANEXO N° 08
CARNÉ DE VACUNACIÓN

PERÚ | Ministerio de Salud

Yo me vacuno contra el dengue

CARNÉ DE VACUNACIÓN CONTRA DENGUE

EE.SS:_____ REGIÓN:_____

Nombres:_____

Apellidos:_____

Domicilio:_____

Tipo Doc:_____ N°:_____

Edad:_____ Distrito:_____

Provincia:_____

N° Celular :_____

Biológicos	Dosis	Fecha	Lote
TAKEDA QDENGA contra el dengue (Vía subcutánea)	1ra Dosis	/ /	
	2da Dosis	/ /	

FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
1ra Dosis	2da Dosis

MINISTERIO DE SALUD - DGIESP - Dirección de Inmunizaciones - V°B° - Dirección Ejecutiva

MINISTERIO DE SALUD - DGIESP - Dirección de Inmunizaciones - Lic. Magdalena del Rosario Quispe Ticona - V°B° - Dirección Ejecutiva

ANEXO N° 09
FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE EVENTOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIDOS A LA VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN (ESAVI) LEVE O MODERADO

CONFIDENCIAL

A. DATOS DEL PACIENTE

Nombres o iniciales:

Edad:	**Sexo** □ F □ M	**Peso (Kg):**	**Historia Clínica y DNI:**

Semanas de gestación (solo gestantes):

Establecimiento donde se vacunó:

B. EVENTOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIDOS A LA VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN (ESAVI)

Describir el ESAVI

Fecha de inicio de ESAVI: ___/___/_____
Fecha final de ESAVI: ___/___/_____

Gravedad del ESAVI (Marcar con X)
□ Leve □ Moderado □ Grave

Solo para ESAVI grave (Marcar con X)
□ Hospitalización
□ Riesgo de muerte
□ Discapacidad
□ Anomalía congénita
□ Fallecimiento Fecha (___/___/___)

Desenlace (Marcar con X)
□ En remisión □ Recuperado □Recuperado con secuela
□ No recuperado □ Mortal □ Desconocido
Se realizó autopsia (mortal): □ Si □ No □ Desconocido

Resultados relevantes de exámenes de laboratorio (incluir fechas):

Otros datos importantes de la historia clínica, incluyendo condiciones médicas preexistentes, patologías concomitantes (ejemplo alergias, embarazo, consumo de alcohol, tabaco, disfunción renal/hepática, etc.)

C. VACUNA (S) SOSPECHOSA(S)

Nombre	Laboratorio	Lote	Dosis 1,2,3	Vía de Adm/Sitio de Adm	Fecha vacunación	Hora de vacunación	DILUYENTE (si aplica) Lote	DILUYENTE (si aplica) Fecha Vencimiento

El paciente recibió tratamiento para el evento □ Si □ No Especifique:

En caso de sospecha de problemas de calidad indicar: Nº Registro Sanitario: Fecha de vencimiento___/___/_____.

D. MEDICAMENTOS UTILIZADOS AL MOMENTO DE SER VACUNADO (excluir medicamentos para tratar el evento)

Nombre comercial o genérico	Dosis/ frecuencia	Vía de Adm.	Fecha inicio	Fecha final	Motivo de prescripción

E. DATOS DEL NOTIFICADOR

Establecimiento/ Institución:

Nombres y apellidos:

Teléfono:	**Correo electrónico:**	
Profesión:	**Fecha de notificación**___./___./_____.	**N° Notificación:**

INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE EVENTOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIDOS A LA VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN (ESAVI)

1. Notifique, aunque Ud. no tenga la certeza de que la vacuna causó el ESAVI. La sospecha de una asociación es razón suficiente para notificar.
2. Notifique todos los eventos esperados o conocidos, inesperados o desconocidos, leves, moderados o graves relacionados con vacunas.
3. No deje de notificar por desconocer una parte de la información solicitada.
4. Si la información solicitada no está disponible, colocar "Desconocido".
5. Utilice un formato por paciente.
6. En caso de no contar con el espacio suficiente para el registro de la información, utilice hojas adicionales.
7. ESAVI grave: También conocido como SEVERO, es todo ESAVI que cumpla uno o más de los siguientes criterios: resulta en muerte, amenaza la vida, requiere hospitalización o prolonga la hospitalización, resulta en discapacidad significativa o permanente, en aborto o una anomalía congénita."
8. **Los ESAVIs graves deben ser notificados dentro de las veinticuatro (24) horas de conocido el caso, y si son leves o moderados en un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas y deberán ser enviados según el flujo de notificación establecido en cada establecimiento.**

A. DATOS DEL PACIENTE

Nombres o iniciales: Registrar los nombres o iniciales del paciente.
Edad: Use como referencia el primer signo, síntoma, hallazgo anormal de laboratorio, se debe expresar de forma numérica en años/meses/días. En caso el dato no esté disponible se podrá colocar fecha de nacimiento (Día/Mes/Año)
Sexo: Marcar con una "X" la opción que corresponda
Peso: Expresarlo en Kg.
Historia Clínica y DNI: Completar la información solicitada.
Semanas de gestación: en el caso de que se trate de un gestante llenar el tiempo de gestación en semanas.
Establecimiento donde se vacunó: Indicar el nombre completo del establecimiento (hospital, centro de salud, puesto de salud u otra institución) donde recibió la(s) vacuna(s).

B. EVENTOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIDOS A LA VACUNACION E INMUNIZACION (ESAVI)

ESAVI: Describa detalladamente cuáles fueron los signos o síntomas que considere puedan estar relacionados con la administración de la vacuna. Describa el evento resumiendo toda la información clínica relevante. Además, señalar el tiempo transcurrido entre la vacunación y aparición de síntomas (días, horas, minutos). Indicar la modalidad de vacunación (programa regular, campaña, barrido o jornada).
Fecha de inicio de ESAVI: Indicar la fecha (Día/Mes/año) exacta en la cual se presentó el evento.
Fecha final de ESAVI: Indicar la fecha (Día/Mes/año) exacta en la cual desaparece el evento.
En caso de existir más de un ESAVI, describa la fecha de inicio y final de cada uno de ellos.
Gravedad del ESAVI: Marcar con "X" la gravedad del evento.
Si el ESAVI es grave marcar con una "X" la(s) opción(es) que apliquen.
Desenlace: Marcar con una "X" la opción que corresponda.
Si el desenlace fue mortal marcar con "X" si se realizó autopsia.
Resultados relevantes de exámenes de laboratorio (incluir fechas): Resultados de pruebas de laboratorio usadas en el diagnóstico del evento.
Otros datos importantes de la historia clínica: Indicar condiciones médicas previas de importancia, así como patologías concomitantes (por ejemplo, Hipertensión arterial, Disbetes mellitus, disfunción renal/hepática, etc.) u otras condiciones en el paciente (por ejemplo, alergias, embarazo, consumo de tabaco, alcohol, etc.).

C. VACUNA (S) SOSPECHOSA(S) / DILUYENTE

Nombre de la vacuna: Colocar el nombre indicado en el rotulado de la vacuna administrada, incluyendo la concentración y forma farmacéutica.
Laboratorio: Colocar el nombre del laboratorio fabricante.
Lote: Registrar las letras y/o números que indica el "lote" en el envase del producto.
Dosis: Indicar el número de dosis administrada.
Vía de administración: Señalar la vía de administración de la vacuna.
Sitio de administración: Indicar el lugar de administración de la vacuna (Ejemplo musculo deltoides derecho
Fecha de vacunación: señalar la fecha (Día/Mes/año) en que se realizó la vacunación
Hora de vacunación: Colocar la hora en recibió la vacuna.
Lote del Diluyente: Colocar el número y/o letras que figuran en el "lote" del envase.
Fecha de vencimiento: colocar la fecha de vencimiento que figura en el envase del diluyente.
El paciente recibió tratamiento para el evento. Indicar si el evento requinó tratamiento (farmacológico, quirúrgico, etc.) y de ser positivo, especificar el tratamiento.
En caso de sospecha de problemas de calidad: Completar la información solicitada.

D. MEDICAMENTOS UTILIZADOS AL MOMENTO DE SER VACUNADO

Registrar los medicamentos que está recibiendo el paciente al momento de ser vacunado. Considerar los productos farmacéuticos prescritos o automedicados. Excluir los medicamentos usados para tratar el evento.

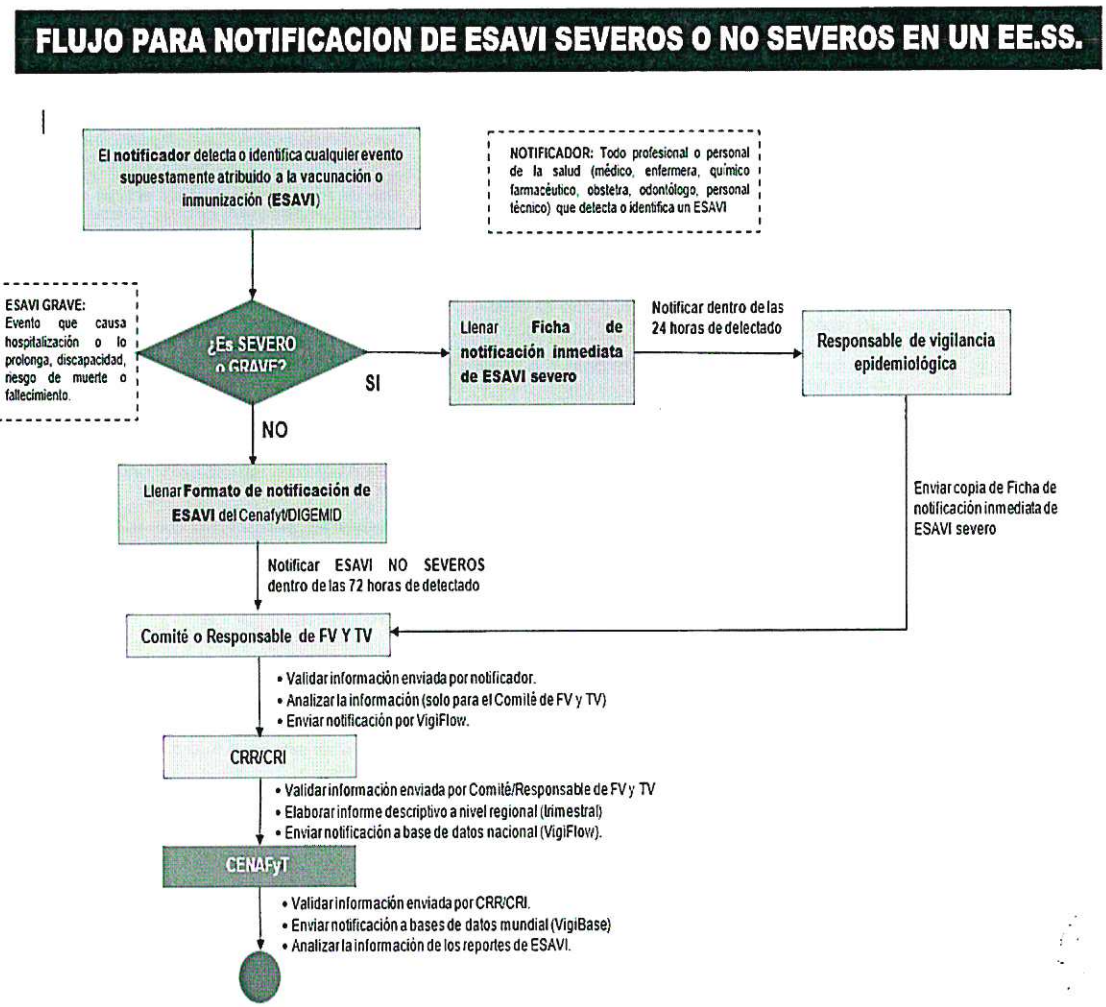
E. DATOS DEL NOTIFICADOR

Establecimiento: Indicar el nombre completo del establecimiento (hospital, centro de salud, puesto de salud u otra institución) donde se detecta el ESAVI.
Nombres y apellidos, profesión, teléfono, correo electrónico (de contacto de la persona): Su objetivo es para solicitar información adicional y/o para canalizar una respuesta del caso notificado si es necesario.
Fecha de notificación: Indicar la fecha (Día/Mes/año) en que se completó el formato.
N° notificación: Este casillero será para uso exclusivo del Centro de Referencia Regional o Institucional de Farmacovigilancia.

Nota: El uso de los datos registrados en el presente formato se enmarca en las disposiciones legales sanitarias vigentes.

Fuente: NTS N° 123-MINSA/DIGEMID-V.01 Norma Técnica de Salud que regula las actividades de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobada por Resolución Ministerial N° 539-2016/MINSA.

ANEXO N° 10
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS U OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (SRAM) O ESAVI LEVE Y MODERADO PARA PROFESIONALES DE LA SALUD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SIN INTERNAMIENTO



Fuente: Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. Documento de orientación. Identificación y Notificación de SRAM, ESAVI u Otro Problema Relacionado con el Uso de Productos Farmacéuticos. Version N°2-2022

ANEXO N° 11
FICHA DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE EVENTO SUPUESTAMENTE ATRIBUIDO A LA VACUNACIÓN O INMUNIZACIÓN (ESAVI) SEVERO

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO NOTIFICANTE	
Nombre del establecimiento de salud	
Teléfono	
Red	
DISA/DIRESA/GERESA	
PERSONA NOTIFICANTE	
Apellidos y nombres	
Teléfono	
Cargo	
DATOS DEL CASO	
Apellidos y nombres	
Teléfono	
Edad y sexo	
Lugar de procedencia	
Fecha de captación	
Signos/síntomas presentados	
DATOS DE LA VACUNACIÓN	
Establecimiento donde se aplicó la vacuna	
Fecha de vacunación	
Hora de vacunación	
Fecha y hora del inicio de síntomas	
Tipo de vacuna aplicada	
Vía de aplicación	
Número de dosis aplicada según calendario	

Fuente: Directiva Sanitaria N° 054-MINSA/DGE-V.01 "Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización (ESAVI)", aprobada por Resolución Ministerial N° 063-2014/MINSA.

ANEXO N° 12
FORMATO DE REGISTRO INDIVIDUAL DE VACUNACIÓN CONTRA DENGUE

PERÚ | Ministerio de Salud

FORMATO DE REGISTRO INDIVIDUAL DE VACUNACION CONTRA DENGUE

A.- GERESA/DIRESA: _____
B.- RED : _____
C.- MICRORED : _____
D.- ESTABLECIMIENTO : _____

ESTRATEGIA DE VACUNACION
E.- SERVICIO DE INMUNIZACIONES
F.- OTRO (especifique)
G.- RESPONSABLE MONITOR (A)
NOMBRES Y APELLIDOS DEL MONITOR _____
DNI DEL MONITOR (A)

H.- RESPONSABLE VACUNADOR Y REGISTRADOR
DNI DEL VACUNADOR: .....
NOMBRES Y APELLIDOS DEL VACUNADOR
DNI DEL REGISTRADOR: .....
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REGISTRADOR:

N° Orden	Tipo Doc / N°de Documento / Nacionalidad	Nombre y Apellido	Sexo (F / M)	Etnia	Fecha Nacimiento (dd/mm/aa)	Edad + Tipo de Edad A: años	Teléfono	Dirección (residencia)	Distrito	Grupo riesgo (M=FFAA / PNP / ST=Personal Salud)	Dosis aplicadas			
											1° DOSIS		2° DOSIS	
											Fecha aplicación	Lote	Fecha aplicación	Lote
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
									TOTAL					

Grupos de riesgo:
M= Fuerzas Armadas, incluye Ejercito, Marina, Naval y FAP
PNP= Policía Nacional del Perú
ST= Personal de Salud (Trabajador de Salud)

Lote:	
Fecha vencimiento	

MINISTERIO DE SALUD - DGIESP - Dirección de Inmunizaciones - V°B° - DIRECTORA EJECUTIVA
V. ALARCON G.

ANEXO N° 13
FORMATO DE REGISTRO CONSOLIDADO DE VACUNACIÓN CONTRA DENGUE

PERÚ | Ministerio de Salud

FORMATO DE REGISTRO CONSOLIDADO DE VACUNACION CONTRA DENGUE

A.- GERESA/DIRESA: _____
B.- RED : _____
C.- MICRORED : _____
D.- ESTABLECIMIENTO : _____

ESTRATEGIA DE VACUNACION
E.- SERVICIO DE INMUNIZACIONES [ ]
F.- OTRO (especifique) [ ]

G.- RESPONSABLE MONITOR (A)
NOMBRES Y APELLIDOS DEL MONITOR
.....
DNI DEL MONITOR (A) .....

NOMBRES Y APELLIDOS DEL VACUNADOR	Dosis	10 años	11 años	12 años	13 años	14 años	15 años	16 años	17 años	18 a 29 años	30 a 59 años	TOTAL
BIRG 1	1°											
BIRG 1	2°											
BIRG 2	1°											
BIRG 2	2°											
BIRG3	1°											
BIRG 3	2°											
BIRG 4	1°											
BIRG 4	2°											
BIRG 5	1°											
BIRG 5	2°											
BIRG 6	1°											
BIRG 6	2°											
BIRG 7	1°											
BIRG 7	2°											
BIRG 8	1°											
BIRG 8	2°											
BIRG 9	1°											
BIRG 9	2°											
BIRG 10	1°											
BIRG 10	2°											
TOTAL	1°											
TOTAL	2°											

MINISTERIO DE SALUD — V. ALARCON G.

MINISTERIO DE SALUD - DGIESP — Dirección de Inmunizaciones — Lic. Mercedes del Pozo Quispe Jefa — V°B° — DIRECTIVA EJECUTIVA

ANEXO N° 14
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS POR LA VACUNACIÓN

ETAPA	DESCRIPCIÓN
ACONDICIONAMIENTO	Consiste en la preparación de los servicios o áreas del establecimiento de salud (EESS), servicios médicos de apoyo (SMA) y centros de investigación (CI) con materiales: Recipientes (contenedores, tachos, recipientes rígidos, entre otros), e insumos (bolsas) necesarios y adecuados para la recepción o el depósito de las diversas clases de residuos que generen dichos servicios o áreas. Para realizar el acondicionamiento es necesario tener en cuenta la información del diagnóstico basal o inicial de residuos sólidos.
SEGREGACIÓN	Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. Consiste en la separación de los residuos en el punto de generación, ubicándolos de acuerdo a su clase en el recipiente, contenedor o depósito correspondiente y es de cumplimiento obligatorio para todo el personal que labora en un EESS, SMA y CI.
ALMACENAMIENTO PRIMARIO	Es el almacenamiento temporal de residuos sólidos realizado en forma inmediata en el ambiente de generación; son los depósitos, contenedores o recipientes situados en las áreas o servicios del EESS, SMA y CI.
ALMACENAMIENTO INTERMEDIO	Es el lugar o ambiente donde se acopian temporalmente los residuos generados por las diferentes fuentes de los servicios cercanos, distribuidos estratégicamente dentro de las unidades, áreas o servicios. El tiempo de almacenamiento intermedio no debe ser superior de doce horas.
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO	Consiste en trasladar los residuos al almacenamiento intermedio o central, según sea el caso, considerando la frecuencia de recojo de los residuos establecidos para cada servicio, utilizando vehículos apropiados (coches, contenedores o tachos con ruedas preferentemente hermetizados).
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EXTERNO	Es la actividad que implica el recojo de los residuos sólidos por parte de la EO-RS debidamente registrada ante la autoridad competente, desde el EESS, SMA y CI hasta su disposición final, cuyos vehículos deben estar autorizados por la municipalidad correspondiente y/o del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Los residuos peligrosos en ningún caso deben transportarse junto con los residuos municipales.
DISPOSICIÓN FINAL	Son procesos u operaciones para tratar y disponer en un lugar los residuos sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura.

Fuente: NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA, Norma Técnica de Salud: "Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud, Servicios Médicos de Apoyo y Centros de Investigación", aprobada por Resolución Ministerial N° 1295-2018/MINSA.

X. BIBLIOGRAFÍA

1) Orientaciones regionales para la vigilancia de seguridad de la vacuna contra el dengue [Internet], Consultado 14 de enero de 2026. Disponible en: https://www.paho.org/es/documentos/orientaciones-regionales-para-vigilancia-seguridad-vacuna-contra-dengue-qdenga-tak-003

2) Ficha Informativa de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y drogas y del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, de enero 2025: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7554391/6418182-ficha-informativa-vacuna-qdenga.pdf?v=1738165907

3) Resolución Ministerial N°884-2022/MINSA, NTS N°196-MINSA/DGIESP-2022 "Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación".

4) Resolución Ministerial N°764-2024/MINSA, "Plan Piloto de implementación de la vacunación contra el dengue en las regiones Tumbes, Piura, Loreto y Ucayali para los años 2024-2025.

5) Resolución Ministerial N°807-2024/MINSA, Lineamientos para la vacunación contra el dengue durante la ejecución del Plan Piloto 2024-2025.

6) Resolución Ministerial N°455-2025/MINSA, "Plan Piloto de implementación de la vacunación contra el dengue en las regiones Tumbes, Piura, Loreto y Ucayali para los años 2024-2025".

MINISTERIO DE SALUD DG V. ALARCON G.

MINISTERIO DE SALUD - DGIESP DIRECTORA EJECUTIVA V°B°